

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	植入主動脈內氣球幫浦機導管之 護理技術評核表	編號	A31000-Q06-F-B35
			版本	第 2.3 版
	制定單位	護理部	修正日期	111 年 11 月 08 日
			頁數/總頁數	1/1

一、評核對象：加護單位護理人員。

二、評核方式：至病人處查核或以口述或實際演練方式表現其 IABP 之護理觀念與技術。

三、評核內容：

1. 導管插入前準備：

- 確認病人，向病人及家屬解釋及說明技術過程並填寫同意書。
- 測量下肢足背 pulse，若有 PAOD 則建議放健肢。
- 測試 IABP 機體功能、檢查氦氣量(壓力為零時需更換新瓶)。

2. 導管插入過程

- 待導管插入後，接上排好的血壓監測組合套 one way 並接上 pressure 導線接上 IABP 機器；氣球端協助接上三路活塞、延長管之接頭，再接於機體上的充氣接頭。
- pressure 歸零，三路活塞關閉病人端，打開大氣端，按 zero 鍵，待出現“0”，即歸零畢。
- 將 IABP 機體上的 EKG cable 接於病人身上，或將 HP monitor 轉接線接到 IABP Input 孔。
- 醫師調整引動的條件，按 fulfill 再按 start 鍵，讓機體運轉。

3. 導管插入後護理

- 注意病人 EKG 及 IABP 波形正確性及使用 IABP 之頻率。
- 每日 1 次協助病患照 X-ray，確定放置是否適當。
- 每小時評估及紀錄病人患肢脈搏強度、末梢血液循環、膚色、溫度及感覺程度。
- 每二小時協助改變姿位及翻身、床頭不可抬高超過 30~45 度。
- 注意心臟和校正器需在水平高度，每 8 小時作一次歸零校正動作；氣球不可停止充氣超過 30 分鐘，以免凝血；禁止由 IABP 導管線路上抽血或注射藥物。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床號	評 核 內 容												正確率 (%)	備 註
			1a	1b	1c	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d	3e		

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%